

CONSULTORIO PSICOLÓGICO	SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD PROCEDIMIENTO DE REFERENCIA (REMISIÓN DE PACIENTES)	Código: PRD-RYC-01 Versión: 01 Fecha: Agosto 2026
------------------------------------	---	---

PROCEDIMIENTO DE REFERENCIA (REMISIÓN DE PACIENTES)

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para la derivación o remisión (referencia) de pacientes a otros niveles de complejidad u otras especialidades médicas (ej. Psiquiatría, Neurología, Urgencias), garantizando la continuidad y seguridad en la atención en salud mental.

2. ALCANCE

Aplica a todos los pacientes del consultorio psicológico cuya condición clínica exceda el alcance de la intervención psicoterapéutica ambulatoria o requiera manejo interdisciplinario.

3. RESPONSABLES

- Profesional en Psicología Tratante.

4. MARCO NORMATIVO

- Resolución 3100 de 2019 (Estándares de Habilitación).
- Ley 1090 de 2006 (Responsabilidad en la intervención psicológica).

5. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

- 5.1. Identificación de la Necesidad: El profesional determinará la necesidad de remitir al paciente basándose en criterios clínicos como: riesgo inminente de suicidio, agitación psicomotora, necesidad de valoración farmacológica, o presunción de patología orgánica de base.
- 5.2. Información al Paciente/Acudiente: Explicar de manera clara y empática los motivos clínicos por los cuales se sugiere la evaluación por otra especialidad, asegurando que el paciente comprenda que es un complemento a su proceso y no un abandono terapéutico.

CONSULTORIO PSICOLÓGICO	SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD PROCEDIMIENTO DE REFERENCIA (REMISIÓN DE PACIENTES)	Código: PRD-RYC-01 Versión: 01 Fecha: Agosto 2026
------------------------------------	---	---

- 5.3. Diligenciamiento del Formato de Remisión: Redactar el documento de referencia (remisión) el cual debe contener: Datos de identificación, motivo de consulta inicial, resumen de la evolución clínica, impresión diagnóstica y el motivo claro de la remisión.
- 5.4. Referencia de Urgencia (Riesgo Vital): En caso de ideación autolítica inminente o brote psicótico, la referencia se hará de forma inmediata hacia la red de urgencias más cercana en Manizales (o la EPS del usuario), activando la red de apoyo familiar para el traslado seguro.
- 5.5. Registro en Historia Clínica: Toda remisión generada debe quedar soportada como un anexo dentro de la Historia Clínica del paciente, dejando constancia de la fecha y la especialidad a la que fue derivado.

6. PUNTOS DE CONTROL PARA AUDITORÍA

- Formatos de remisión completamente diligenciados y anexos a la HC.
- Trazabilidad en la evolución clínica sobre los motivos de la remisión.

Elaboró: _____

Aprobó: _____